

实用新 脉学

赵德田 编著

黑龙江科学技术出版社

样 本 库

实用新脉学

赵德田 编著



黑龙江科学技术出版社

1987年·哈尔滨

1166070

21010/323107

封面设计：李 伟

实用新脉学

赵德田 编著

黑龙江科学技术出版社出版

(哈尔滨市南岗区建设街 35 号)

依安印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行

787×1092毫米32开本2.25印张43千字

1985年8月第1版·1987年8月第2次印刷

印数：16,201—21,200册

书号：14217·097

定价：0.53元

070

前 言

脉诊是中医诊法之一，是中医宝库中的一项重要内容。在继承和发展中医学的过程中，对脉学进行发掘和整理是一项重要工作。已见到的有关脉学著作（包括目前中医院校教材）基本上都属于古典脉学范畴。中医学需要有继承，也必须有发展，否则就失去了它的生命力。在目前中医现代化的洪流中，本书试图作一点在中医发展道路方面的探索和革新的尝试。

本书有以下特点

一、为使医学临床工作者和教学工作者了解有关脉学的理论源流，书中尽量全面地收录了历代有关脉学的各种有代表性的理论，并给予了适当的评论。

二、把传统的二十八部病脉进行归纳后，合并为二十二部。每部脉分脉象、机制、临床意义三项予以介绍。在脉象方面，基本是综合了历代医家理论并结合临床实践和观察予以具体化和通俗化，有的地方按临床实际观察结果进行了适当修正。在机制方面，除用中医理论解释外，还结合了现代医学，用生理和病理机制进行了解释。临床意义（即主病）则主要根据临床病例观察和统计而得来。

三、对脉学的有关传统理论进行了适当的探讨。

为了把脉学理论向前推进一步，书中提出了一些新的观点。限于本人水平，书的内容，特别是这些新的观点是否得当，切望广大同道和读者正其谬误之处，矫其偏颇之论，使之臻于完善。

目 录

一、脉诊的一般现状	(1)
二、脉诊的发展简史和主要文献	(4)
三、脉诊与疾病	(9)
四、诊脉的部位	(11)
五、诊脉方法和注意事项	(15)
六、脉诊的一些具体问题	(20)
1. 三部九候及分候脏腑	(20)
2. 关于脉的胃气、神、根	(22)
3. 四时脉及四塞脉	(24)
4. 五脏脉	(25)
5. 脉的分类和纲脉	(27)
6. 脉诊和预后	(27)
7. 关于正常脉象	(30)
七、病脉	(32)
1. 浮脉	(32)
2. 沉脉(附:伏脉)	(34)
3. 迟脉	(36)
4. 数、动脉	(38)
5. 疾脉	(40)
6. 虚脉(附:芤脉)	(41)
7. 实脉	(42)
8. 滑脉	(44)

9. 涩脉 (45)	10. 弦脉 (46)
11. 长脉 (48)	12. 短脉 (49)
13. 洪脉 (50)	14. 微脉 (52)
15. 细脉 (53)	16. 软脉(濡脉、弱脉) (55)
17. 紧脉 (56)	18. 革脉 (57)
19. 牢脉 (58)	20. 缓脉 (59)
21. 促脉、结脉、代脉 (60)	22. 散脉 (61)
附：怪脉.....	(62)
八、关于相兼脉象和脉症从舍.....	(64)
附：主要参考书目.....	(66)

一、脉诊的一般现状

脉诊在古代很被人们重视，直到现在也仍不失为一种有意义的诊病方法。但是多年来它的发展一直很慢。近年来中医在临床上对某些疾病的治疗有了很大发展，辨证施治体系也增加了许多新内容，相形之下，中医的诊查手段就相对落后了。如不改变这种现象，势必影响中医辨证施治以及整个中医理论体系的发展。

古代医家诊病重脉而轻症，而现代则有重症而轻脉的趋势。所以，中医诊断学（尤其是脉学）的发展不但有理论意义，也有重要的临床实践意义。就脉学而言，多年来一直没有突破晋代的《脉经》和明代的《濒湖脉学》的规范，仍保持着古典脉学的特色。中医在保持特色（应为特长）的基础上实现现代化是不可否定的发展规律，所以脉学也应走这样一条发展道路。中医学是实践性很强的医学，历代医家都是在实践中发展和完善了中医理论。脉学本身就是一门临床实践科学，因此它也必须在临床实践中不断充实、发展和提高。

目前，中医症状学正在向规范化发展，中医脉学也应如此。在诊脉过程中向来受医生主观因素影响之处甚多，同是一部脉，不同医生会诊出不同结果。其原因除由于理论上和概念上的不具体和不规范外，医生的主观理解和感觉不同也

是个重要因素。要解决这个问题必须从以下两方面着手：其一是在理论上必须作到术语概念清楚具体，使各脉规范化，在描写上要用定量语言，而不要用模糊语言和比喻语言；其二是诊脉方法必须客观化，避免主观意识和成见的干扰。目前已有多种脉搏描记仪出现，这是诊脉客观化的开端。但这种方法由于仪器笨重、价钱昂贵，不便于随时随地应用，故只适用于研究。况且脉搏描记仪往往因探头压力的改变而改变了描记图形，所以也并不十分精确，尚需将仪器进一步改进，使其更臻完善。

现在，中医在临床诊断上所用名词术语和过去比已有很大差异，但脉学所用术语仍然无大变动，因此脉学和临床要求之间有一定距离。如《中医学基础》诊断部分记载：代脉的主病是“脏气衰微”。这种术语因其过于笼统模糊，在临床上已根本无人应用。况且代脉的主病根据临床实践证明，远非“脏气衰微”的问题，它可见于多种疾病中。因此脉学的更新和中医理论一样，要密切结合临床实践，要有个再实践过程。对各脉主病，不能再用抄古书的方法，而是要用临床观察和统计的方法来规定，例如要确定弦脉的主病，就应将大量确定有弦脉的人（包括病人和正常人）进行调查分析并用统计学处理后，看弦脉和哪些病证有必然关系。用这种方法确定的各脉主病就更富于科学性和正确性。本文在这方面作了点初步尝试。

在临床中给脉诊以正确估价也是个重要问题，过高或过低地估价脉诊的临床价值都是错误的。脉搏是一种体征，并非一切病症都可以表现在脉搏上，因此诊脉只是诊查方法之

一，不能代替其它诊法，由于疾病变化表现极其复杂，所以只凭中医四诊是远远不够用的，必须增加更多现代化的、客观的诊查手段才能提高诊断率，这也是正待积极探求和改进之处。

二、脉诊的发展简史和主要文献

据文字记载，最早用切脉诊病的是战国时期的大医家秦越人（扁鹊），他在广泛的医疗实践中运用脉诊，并且诊断技术高明。他著有《扁鹊内经》、《扁鹊外经》，可惜已失传。有人（崔玉田等）怀疑现在的《黄帝内经》即由秦越人成书，但尚无可靠证据。据《难经·序》及《难经译释·绪言》的记载，《难经》一书相传为秦越人（扁鹊）所著。在这两部经典著作中都有大量脉学记载。尤其《难经》一书几乎成为脉学专著。所以扁鹊不但是脉学的创始人，而且对脉学的发展和传播也起了很大作用。

目前可见到的记载脉学的书籍仍以《黄帝内经》为最早，《难经》在《内经》之后成书。但《难经》为扁鹊所著，扁鹊系战国时人，据考证认为《黄帝内经》应成书于战国至秦汉时期，而《难经》又是在《黄帝内经》之后成书，故《难经》的问世应在战国以后或秦汉以后，这样与扁鹊的生卒年代不相符合。所以《难经》的著者和《黄帝内经》及《难经》的成书年代仍然是值得质疑的。

《黄帝内经》中有关脉学的论述很多且较详细，在诊脉部位方面叙述了三部九候法（遍诊法）、人迎气口法和寸口法。同时也论述了诊脉方法、四时脉、五脏脉、五脏病证的

六纲脉（大、小、缓、急、滑、涩）。对脉症的顺逆、脉的胃气、真脏脉、孕脉等也有较详细记载。

三部九候法（遍诊法）首载于《内经》无疑。如《素问·三部九候论》说：“故人有三部，部有三候，以决死生，以处百病，以调虚实，而除邪疾。帝曰：何谓三部？岐伯曰：有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者，有天有地有人也，必指而导之，乃以为真”。

《内经》也记载了人迎寸口法。如《灵枢·禁服篇》说：“寸口主中，人迎主外，两者相应具往具来，若引绳大小齐等。春夏人迎微大，秋冬寸口微大。如是者，名曰平人。”又如《素问·六节脏象论》说：“故人迎一盛，病在少阳，二盛病在太阳，三盛病在阳明，四盛以上为格阳。寸口一盛病在厥阴，二盛病在少阴，三盛病在太阴，四盛以上为关阴，人迎与寸口俱盛四倍以上为关格。关格之脉赢，不能极于天地之精气则死关。”后来《伤寒论》又在人迎寸口法的基础上加上趺阳脉的诊法而首创人迎、寸口、趺阳法的三部诊法。

独取寸口诊法在《内经》已有了明确的记载。如《素问·经脉别论》说：“食气入胃，浊气归心，淫精于脉……气归于权冲，权冲以平，气口成寸，以决死生。”又如《素问·五脏别论》说：“帝曰：气口（即寸口）何以独为五脏主？岐伯曰：胃为水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃以养五脏气，气口亦太阴也。是以五脏六腑之气味，皆出于胃，变见于气口。”这都说明了独取寸口可以诊五脏六腑之病。以后在《难经》中又对独取寸口的某些具体问题作

了叙述。后来《脉经》中又有了更多、更详细的记载和发挥。所以三部九候法、三部法、独取寸口法，皆在《黄帝内经》中奠定了基础。只不过《伤寒论》对三部法作了发挥，而《难经》、《脉经》对独取寸口法作了详细发挥。

《难经》对脉诊的主要贡献是提出了独取寸口法。并把寸口详细分成寸、关、尺三部，又把寸、关、尺三部分成浮、中、沉三候，合称为三部九候法，这个三部九候，有别于《内经》的三部九候法。《难经》对寸、关、尺还具体的划分了尺寸。如第二难说：“……脉有尺寸何谓也？……故分寸为尺，分尺为寸，故阴得尺内一寸，阳得寸内九分，尺寸始终一寸九分，故曰尺寸。”《难经》对寸、关、尺三部候脏腑也有论述，如第十八难说：“脉有三部，部有四经，手有太阴阳明，足有太阳少阴，为上下部何谓也？然手太阴阳明金也，足少阴太阳水也，金生水，水流下行而不能上，故在下部也。足厥阴少阳木也，生手太阳少阴火，火性上炎而不能下，故为上部。手心主少阳火，生足太阴，阳明土，土主中宫，故在中部也。此皆五行子母更相生养者也。”据这段论述，脉有三部即寸、关、尺，部有四经。共有十二经：上部为寸，中部为关，下部为尺。手太阴（肺）、阳明（大肠）及手太阳（小肠）和少阴（心）为上部属寸；足太阴（脾）、阳明（胃）、足厥阴（肝）、少阳（胆）应为中部属关；足太阳（膀胱）、少阴（肾）为下部属尺。这段文字初步把十二经分配到寸、关、尺。这种分法是以五行生克的道理说明的，和现在的分法大致相同。但其是否合适尚待研究。

《难经》对脉的记载主要继《黄帝内经》之说。《难经》

的成书晚于《黄帝内经》，《难经集注·序》说：“《难经》是秦越人叙述黄帝内经，采摘精华，假设问答解释疑难之作。”

继内、难之后，张仲景的《伤寒论》、《金匱要略》对脉诊也有许多记述。但该书并非专门论述脉学的书籍，只是在病症的论述中提到脉象。仲景在《伤寒论》中将脉分为阴阳二类，即浮、大、动、数、滑为阳；沉、迟、弱、弦、微为阴。仲景在该书里独创地提出高、章、纲、慄、卑、损等脉。这些脉象和后来的许多其他医家所论述的脉名异而实同，实际上是无法区别的。

以上几部经典著作中提出了有关脉诊的基本理论，为以后脉诊的发展奠定了良好的基础。在此基础上，西晋·王叔和总结了前人的经验并通过自己的实践和发挥，著成《脉经》一书。此书应算可见到的中医医籍中全面细致地论述脉学的最早专著。此书对《难经》的独取寸口法加以详细论述，使其更臻完善。《脉经》中将寸、关、尺明确划出尺寸，把脏腑具体分配于两手寸、关、尺三部，并且对许多病脉、怪脉、及诊脉对病的预后等都有较详细的论述。此书对后世脉学的发展起了重要作用，在脉学方面直至今日，仍未脱离出此书的范围，不失为一部重要的脉学专著。

继《脉经》之后，又有伪托王叔和名的《脉诀》出现。据考证，此书不是王叔和著，但究竟系何人所著尚不甚清楚。任应秋氏认为该书系六朝人高阳生所著，但李时珍则认为高阳生为五代人，其究竟系何时人，尚未查清。《脉诀》的主要内容包括脉赋、诊脉候入式歌、五脏六腑脉歌、脉类、

左右手诊脉歌、诊生死顺逆歌、察色观病歌、好人歌、诸杂病脉等。任应秋主张推荐初学者读此书，但也有人认为该书错处甚多，如戴启宗著的《脉诀刊误》即对《脉诀》进行了批判。

此后，有关脉学方面的重要著作尚有宋·崔嘉彦的《四言脉诀》，宋·刘元宾的《脉诀机要》，元·滑寿的《诊家枢要》等，其中较为有影响的且有权威的还推明·李时珍的《濒湖脉学》，此书是李时珍在总结前人经验的基础上，结合其父和其本人的实践经验著成，该书运用歌诀形式叙述了病脉27种，诚为后世学习脉学的良书。除此而外，明·李中梓的《诊家正眼》、明·张介宾的《景岳全书·脉神章》、清·张璐的《诊宗三昧》、清·周澄之的《周氏脉学四种》、清·周学庭的《三指禅》、清·林之翰的《四诊抉微》等对脉诊都有一定的贡献。另外尚有些并非脉学专著面谈及脉学的书籍和一些影响并不很大的脉学书籍这里就不一一叙述了。

解放后出版的脉学专著也很多，其中影响较大的有以下几部：上海中医文献研究馆编的《脉诊选要》，汇编了各种有关脉学的主要文献，对研究中医脉学古典文献很有帮助。任应秋编著的《脉学研究十讲》对脉学某些理论有所革新。较为有新思想的还是崔玉田等人编著的《中医脉学研究》，该书对脉学进行了中西医结合方面的研究，并介绍了脉搏描记器。

三、诊脉与疾病

很多疾病可以在脉搏上表现出来，通过诊脉可以诊知一些疾病，这是没有问题的。然而也并非所有的病都可见于脉，这也是事实。到底哪些病可以见于脉，通过什么机制，这是值得研究的问题。

《素问·五脏别论》说：“气口何以独为五脏主？岐伯曰：胃者水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃以养五脏气；气口亦太阴也，是以五脏六腑之气味，皆出于胃，变见于气口。”这段文字说明胃为水谷之海，以五味之气荣养五脏之气，五脏六腑和胃有关，而且五脏六腑的情况都可以从气口（即寸口）表现出来。《素问·宣明五气篇》说：

“心主脉。”《灵枢·脉度篇》说：“阴脉荣其脏，阳脉荣其腑……其流溢之气，内溉脏腑，外濡腠理”这又说明脉和心脏有关，脉对脏腑和腠理都有灌溉和濡养作用。同篇又说“肺朝百脉”，“气口也太阴也”。说明全身的脉都要通过肺，而肺（太阴）脉直接表现在寸口。这样全身脏腑及四肢百骸、腠理都通过脉和肺、气口联系起来，因此全身的疾病可以表现在气口上。

从现代医学理论看，脉搏的形成和心脏功能情况，血管状况、血容量和血液成分有直接关系，而心脏搏动、血管及血

液三者又间接地和许多其它因素相关。除心血管疾病本身可以影响脉搏的改变外，还有许多其它全身疾病可以直接和间接影响脉搏的改变。如发热，休克，胶原病，肾病，血液病，水、电平衡紊乱，神经内分泌失调等。但也有些疾病在某一阶段上或根本不表现在脉搏上，所以单靠脉搏来诊病是不可靠的。

何种疾病可以表现在脉搏上，而何种疾病不能表现在脉搏上呢？这个问题目前尚无人作出明确解答。笔者认为这要看这种疾病能否影响到心脏功能、血容量、血液成分和血管状况而定，与此四者没有直接关系的疾病往往不能使脉搏出现改变（病态的）。尤其是以人手指主观感觉出来的改变，而不是以精密仪器测试出来的改变。如一般的皮肤病、没有严重并发症的轻微外伤、轻微的腹泻和便秘等都不一定在脉象上表现出来。相反如前述之可以影响心血管和血液因素的疾病则可能使脉搏有所改变。

由此可见，切脉是一个重要诊断方法，但不是唯一的，万能的诊断方法。

四、诊脉的部位

人体有脉搏之处很多，究竟于何处诊脉，古今文献记载甚多。一般来讲，凡有脉搏之处皆可诊之，故古人有遍诊法。但于全身诊脉存在以下几个问题：

（1）由于血管的粗细不一样，相应的血管壁之厚薄也不一样，所以对脉的性状无法规定一个统一标准，如粗细、大小、长短等；

（2）由于血管于人体的深浅部位不一，故也无法定浮沉之说；

（3）有些部位的脉不能随时诊察。如遍诊法中的下部天须诊足厥阴气冲下三寸动脉五里处（股动脉），此处诊察起来很不方便，尤其对女人更不宜作常规诊察，因此，古人规定女人可诊太冲处代之。

如果单为了诊得脉搏的至数和节律，那么全身的动脉都可以作为诊脉之处。如果要诊脉搏的性状（脉象），则必得固定一处脉搏才行。目前在一般情况下都采用独取寸口法是有一定处理的。然而在病情危重时，如厥逆或垂死时（严重的休克和心跳突停），欲知脉之有无，则需要诊人迎脉（颈动脉）和五里脉（股动脉），单诊寸口脉是不行的。

关于诊脉的部位，自古至今有很多记载，总括起来有以

下几种：

(1) 三部九候法（遍诊法）

此法是把人体可诊脉之处，大体分成上、中、下三部，每部又分天、地、人三候，故称三部九候法。上部于头部诊之，中部于上肢诊之，下部于下肢诊之。具体部位如下：

上部天：诊两额动脉。当含厌之分（颞浅动脉之额支），以候额角之气。

上部人：诊耳前动脉。当和髡之分（颞浅动脉），候耳目之气。

上部地：诊两颊动脉。地仓、大迎之分（面动脉），候口齿之气。

中部天：诊手太阴寸口之脉（桡动脉），候肺之气。

中部人：诊掌后锐骨下动脉。神门之次（尺动脉），候心之气。

中部地：诊手大指、次指歧骨间动脉，合谷之次（桡动脉）候胸中之气。

下部天：足厥阴也，诊气冲下三寸动脉。五里之分（股动脉，女子可取太冲），候肝之气。

下部人：诊足太阴五里下期门之分（股动脉），候脾胃之气。

下部地：足少阴脉，诊内踝后跟骨旁动脉，太溪之分（胫后动脉），候肾之气。

此法首载于《黄帝内经》，虽现在已不被应用，但仍有重要的临床应用价值。诊察每个局部的脉搏可以了解每个局部的血液供应情况。全身各处脉搏的改变并不是一致的，单

诊一处的脉搏而对全身脉搏情况作出结论是片面的，故遍诊法仍有提倡的必要。

(2) 人迎寸口法(三部法)

人迎寸口法即诊人迎脉和寸口脉，此法亦首载于《黄帝内经》，后来《伤寒论》中又加上趺阳脉而成为三部法。

人迎即颈动脉。诊察部位于气管旁相当于结喉处稍上，用手指向后、稍偏内压即可诊知。诊察颈动脉窦过敏者须谨慎。

寸口即两手之寸口脉(桡动脉)，此两处都是较易诊察处，而且又较常用。

寸口脉的诊断意义详见本书第三节。关于人迎脉的诊断意义，《内经·六节脏象论》说：“人迎一盛病在少阳，二盛病在太阳，三盛病在阳明，四盛以上为格阳。……人迎与寸口俱盛四倍以上为关格，关格之脉羸，不能极于天地之精气则死矣。”所谓一盛即盛大一倍之意。人迎一盛即指人迎脉比寸口脉盛大一倍，依此类推。人迎脉在人体生理解剖上比寸口脉粗大，故正常的人迎脉都应比寸口脉盛，而相反寸口脉比人迎脉盛似不应存在，当然这里的盛大不单指粗大，也指搏动有力而言。不过单凭几盛而定病在何处好象很牵强和片面，不一定可信。三部法之趺阳脉(即诊足背动脉，以候胃气)用来诊断脱骨疽很有意义。除此以外，人迎脉用在危重症抢救时或观察头部的供血情况亦很有用，故此法也不可废弃。

(3) 独取寸口法

所谓独取寸口即单独诊寸口脉(腕部的桡动脉)。寸口也

叫气口，脉口。

关于寸关尺的尺寸划分，蔡氏在《四诊抉微》里说：“自肘中至鱼际得同身寸一尺一寸，自肘前一尺为阴之位，鱼际一寸为阳之位。太阴动脉，前不及鱼际横纹一分，后不及肘中横纹九寸，故古人于寸内取九分为寸，尺内取一寸为尺。以契阳九阴十之数。”即说以同身寸的长度，位于鱼际后横纹处算起，去掉一分，另取一寸九分为寸口脉的长度。以高骨定关，关前为寸、关后为尺。有人（崔玉田等）对《难经》第二难的解释认为“关”只是分界线，没有长度位置。还有人将一寸九分之寸口脉又在左关前分出人迎，右关前分出气口，并把寸、关、尺分成均匀的三等分。这似乎没有多大意义，与实际不符且不利于临床应用，故应仍以高骨定关，关前为寸，关后为尺为宜。况且寸口脉也并非只有一寸九分，因此对具体尺寸不必苛求，不能说在同一条动脉上超出一寸九分就不是寸口脉了。

寸口脉是目前在中医临床中诊病应用的唯一诊脉部位。在没有特殊情况时，诊寸口脉还是方便的。但也不可过于偏激，在寸口脉诊不到时，诊人迎和五里脉可以帮助了解脉搏的有无、节律和脉率。诊每个局部脉对了解局部病变情况也是很有帮助的。

五、诊脉方法和注意事项

古人对切脉方法,要求比较严格。根据脉诊书籍的记载,归纳起来,诊脉时应注意以下几个方面的问题:

(1) 诊脉时间

根据《黄帝内经》的要求以“平旦”为佳。如:《内经·脉要精微论》说:“诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀、气血未乱,故乃可诊有过之脉。”诊法所以必须平旦,是因为“阴气未动,阳气未散。”所以“阴气未动,阳气未散”是因“饮食未进”,正因为以上的因素,才能“经脉未盛,络脉调匀,气血未乱”,在这种情况下,才能诊出“有过(病)之脉。”此段论述很精辟,但未扩展开来,引深下去,如时间的“平旦”问题,所以要“平旦”是因经一宿的安静休息,病人尚未受到活动、饮食、药物、精神因素的干扰而影响真实脉象的表现。假如在平旦以外的其它时间符合以上条件,同样可以达到以上目的。反之,假如病人在夜间没有得到很好休息,同时又有药物的干扰,那么“平旦”也便失去了意义。所以在时间问题上不必拘泥,只要符合上述条件即可。况且现在的诊疗条件并不能达到“平旦”去病榻前诊病的要求,因此要求必须“平旦”时诊脉是不符合临床工作实际情况的。

（2）病人的准备

诊脉时对病人的要求是去除其它客观因素的干扰，这样所表现出来的脉象才是“本来”（或“基本”）脉象。因此，诊脉以前病人应有一定时间的休息（包括体力上的和脑力上的），并应平心静气，排除精神和思想上的干扰，休息时间应在15分钟以上方可诊脉。诊脉前不宜应用拟神经制剂，如中枢神经兴奋药、抑制药，拟交感神经、副交感神经等药物；不宜饮浓茶与饱食。

（3）病人和医生的姿势

病人的姿势可根据具体情况而定。一般门诊病人采取坐位，臂前伸稍外展、微屈，肌肉放松，腕部大约和心脏呈水平，掌心向上即可。住院病人可根据病情，采取坐位、半卧位、卧位均可。如采取坐位或半卧位，基本与门诊病人姿势相同。如病人卧位时应采取仰卧位，手臂姿势同坐位。临床一般不采取俯卧位和侧卧位诊脉。无论取什么体位，病人袖口不宜紧，也不应有其它衣物等勒扎臂部，以免影响脉象的真实程度。

医生的姿势要求于诊脉方便，于病人方便。过去要求以医生左手诊病人右手，医生右手诊病人左手为正规，其实没有必要。医生坐位、立位皆可。

（4）布指法

布指法大致可分为手指的分配部位和诊察方法两类。

医生手指的分配方法一般是以中指定关（按在病人高骨处）食指定寸，无名指定尺。但以食指定尺，无名指定寸也未尝不可。手指的疏密要根据病人的前臂的长短而定。前臂

长者布指稍疏，前臂短者布指稍密，密者手指可相并。疏者可指距2—5毫米。如果再宽可能使指位超过一寸九分，当然这不是绝对的。

关于医生应用手指什么部位诊脉的问题，卢子由在《学古诊则》中说：“指头齐平，节节相对”、“用指端棱起如线者名曰指目，以按脉之脊。”所谓指目即指指的掌面和指端交界之处。有人认为此处感觉最敏锐，有如人之眼目，故名指目。因为指头齐平时，指端的掌面很难成一条线，无法按同一条血管。而以指端按脉则面积又太窄，很难诊知脉的全貌，所以用指目诊脉是最好的办法。

关于诊脉方法 古籍记载很多，总结起来不外举、按、寻和单按与总按。

举、按、寻即轻、重、中按，以分脉之浮、沉、中，至于何谓轻、重、中按却只能依靠人的主观感觉而定。《难经·五难》说：“脉有轻重何谓也？然，初持脉如三菽重，与皮毛相得者，肺部也；如六菽重，与血脉相得者，心部也；如九菽重，与肌肉相得者，脾部也；如十二菽重，与筋平者，肝部也；按之至骨，举指来疾者，肾部也。故曰轻重也。”这里将切脉的轻重说的很具体。菽，小豆也。所谓三菽系指每手三部脉三菽，即每部一菽重。六菽则每部二菽，依此类推。这里的脏腑分配不是以三部九候的原则，而是依所按轻重的原则，与通用方法不符，故不宜采用。以菽权轻重亦不便于临床应用，故只能学其理而不能效其法。我们在临床应用时，一般来说刚接触到皮肤即为轻取（举），用力按而不接触筋骨即为重取（按），介于轻重之间者为中（寻），

按至筋骨为最重取，用以诊伏脉。轻取最明显的脉叫浮，重取最明显的脉叫沉，中取最明显的脉为中。举、按、寻是区别脉浮、沉、中的办法。也是区别脉深浅部位的方法。若区别各部脉的性状则须用推、持、单按与总按的方法。

推，系指手指处于脉管垂直的方向，横着推寻脉的粗细和性状，有内推、外推之分。持，有久持之义，指长时间的持脉，上下左右寻求脉的性状。单持是指单诊一部脉的意思。总按是指三指齐按。

《中医诊断学讲议》第二版（广州中医学院主编）引《重订诊家直诀》之说，认为单按与总按不同，即同一部脉在单按和总按时有不同的结果。这种情况尤以寸，关两部为著。致成这种情况的原因是尺脉在血流源头方向的影响，单按时，该部脉的前向（血流源头方向）没有阻力，总按时于尺脉处施加了压力，该部脉的前向有一定的阻力，所以结果是不同的。各部的脉象应以单按为主，总按则用以确定脉的节律和脉率以及诊察脉象总结情况。

张翼在《谈切脉》中主张八岁以下用一指定三关诊法，三岁以下用看指纹法代替诊脉。其实成人也未尝不可以用一指定三关法。《重订诊家直诀》中提到“一指直压法”即是此义。三岁以下小儿可以看指纹，但不可完全废弃诊脉，诊脉仍有重要价值，不可偏废。

有人主张浮候用可诊腑、沉候用以诊脏、中候用以诊脉之有无胃气，这种说法似不恰当。切脉时，浮、中、沉必取其一，不可能三部皆取，如三部皆取则脉的浮、沉便失去其

意义了。同一部脉同时浮、中、沉三候皆取，结果肯定不一样，这样也没法给这部脉作结论了。所以无论诊脏腑者胃气，必须在浮、中、沉任一候中去取才对。

六、脉诊的一些具体问题

1. 三部九候及分候脏腑

三部（寸、关、尺）及其分配脏腑，自《内经》以来有许多学说，但都和《内经》大同小异。兹将几部主要脉学书籍对寸、关、尺三部分配脏腑的记载列表如下：

寸关尺分配脏腑表

文 献	部 位 脏 腑	寸		关		尺	
		左	右	左	右	左	右
内 经		心、膻中	肺、胸中	肝、膈	脾、胃	肾、腹中	肾、腹中
难 经		心、小肠	肺、大肠	肝、胆	脾、胃	肾、膀胱	肾、命门
脉 经		心、小肠	肺、大肠	肝、胆	脾、胃	肾、膀胱	肾、三焦
景岳全书		心、包络	肺、膻中	肝、胆	脾、胃	肾、大肠膀胱	三焦 肾、小肠 命门
医宗金鉴		心、膻中	肺、胸中	肝、膈胆	脾、胃	肾、膀胱 小肠	肾、大肠

（此表自《中医诊断学讲义》第二版改编）

从上表看，诸书关于五脏的分配是完全一样的，只有六腑的分配有差异，有的书籍把非六腑的内容也分配进去了。

如《内经》、《景岳全书》、《医宗金鉴》将膻中、膈、胸中、命门等划进去，过于繁杂似没必要。上表中较为合理的是《难经》和《脉经》的分配方法。《难经》和《脉经》关于寸、关、尺分配脏腑的区别是《难经》右肾是命门，《脉经》的右肾是三焦。但三焦包括了所有的脏腑、似不应单设一部候诊。命门亦可以包括在肾的范围以内，单提出来也不一定合适。所以两尺部应该都候肾和膀胱为好。单就历代文献的分法而言，仍以《难经》的分法为佳。

这里要提出讨论的是这种三部分候脏腑法是否真有其物质基础、理论根据和实用意义。这个问题很早就有人提出讨论过并有不同看法，笔者也略有同感。许多脉学书籍都提出了不同看法，但最后都没有结论，因为这些都是假说，没有以实验的方法找到客观依据。

关于三部分候脏腑问题，明·李时珍说：“两手六部皆肺之经脉也，特取此以候五脏六腑之气耳，非五脏六腑所居之地耳。”说明寸、关、尺三部脉都是一条动脉。“非五脏六腑所居之地耳”，那么为什么能候五脏六腑之气呢？据清·张登的意见，“要知两手三部，咸非脏腑定位。不过假道以行诸经之气耳。”即非脏腑定位，为什么假道以行诸经之气呢？假道者，何也？仍不明白。以上两位医家也提出质疑，而不持肯定的意见。如果说五脏六腑之病变可以在整个寸口脉中表现出来，而不必详细把三部分候脏腑，倒是有点道理的。一寸九分长的一段动脉每六分长表现一个脏腑的情况似乎有点玄妙和机械。当然完全以现代医学观点来看待祖国医学不一定合适，但祖国医学理论如脱离辩证唯物主义也是

不合适的。

临床中很少见到某脏之病变单见于该脏所应之一部脉，偶有相合，未经统计学处理，也无法估计它的意义。故三部分候脏腑之说尚待进一步研究。

2. 关于脉的胃气、神、根

脉的胃气即人体胃气在脉上的表现，而不是脉搏本身另有胃气。张翼在《谈切脉》中说：“所谓脉之胃气即指人的消化吸收功能和营养状态。”《素问·玉机真脏论》说：

“胃者五脏之本，脏气不能自至于手太阴，必因于胃气乃至于手太阴也。”说明各脏之气所以能见于寸口脉，便是胃气的作用，否则如无胃气便是真脏脉现。《素问·平人氣象论》又说：“胃者平人之常气也，人无胃气曰逆，逆者死。”说明胃气是常人之气。所谓常人之气即指正常人的表现，正常人的脉搏必须是有胃气的，故此种含义和第一种说法无甚区别，也是指水谷之气，消化功能。第二者谈的使各脏气见于寸口的功能，也即指有胃气也，无胃气便是真脏脉现。总结前三者说法，脉之胃气即指人体的胃气，消化功能，水谷之气。

关于脉的胃气和表现有以下一些说法：《素问·玉机真脏论》说：“脉弱以滑是有胃气。”《灵枢·始终篇》说：“邪气来也紧而疾，谷气来也徐而和。”朱改之的意思是脉来健旺而柔和，微弱而应指便是胃气。张景岳说：“雍容缓和之状便是胃气之脉。”林之翰在《四诊抉微》中说：“凡脉缓而和匀，不浮不沉，不大不小，不疾不徐，不长不短，

应手中和，意思欣欣，悠悠扬扬，难以名状者，此真胃气脉也。”这段话是对脉的胃气的全面总结。这段有关脉的胃气的描写，也写出了正常脉象的特点。脉的有胃气就是正常脉象的表现。正因为人有胃气，脉象才正常，才不能出现真脏脉。如何诊脉的胃气的有无，其说法也有不同。有人主张须用三部齐按法，可是真脏脉却应见于本部，也可见于三部，故诊脉胃气之有无还是以三部齐按为好。也有人主张用中候以诊胃气这是不正确的，该脉属那一候就在那一候诊才对。

脉的神根据《中医诊断学讲义》第二版的解释为：脉神是心神的表现、心神健旺，脉自有神，心神有病脉自无神。神的表现是脉来柔和；微弱之脉不失有力；弦实之脉不失柔和，脉的神和胃气是一样的，有胃气即有神，胃和神的诊法也一样。李东垣认为脉神的表现是“有力”二字，林之翰同意此说。王执中说：“有神者，有力中带光泽润泽也。”然而脉象是无法诊出“光泽”来的。此光泽应和润泽为同意语为对。萧子颐说：“轻清稳厚肌肉里，不离中部象自然。”然而“轻清”、“稳厚”和“光泽”一样，都是一种模糊而微妙的概念。一般书都认为脉的神主要是柔和、冲和、有力、律正、率中。可见脉的神和胃气无甚区别。

所谓脉的根系指脉的根本，有如树的根本一样，有根无叶可以生长，有叶无根必当枯死。脉之根也有同样作用。关于脉根说法也不统一。《四诊抉微》载汇辩说：“一以尺中为根……一以沉候为根。”以尺中为根者以肾为根也，以沉为根者以里为根也。亦即寸关虽无、尺脉犹存，谓之有根，疾病预后较好。浮取虽无，沉取则有也谓之有根，预后亦较

好。《中医诊断学讲义》第二版综合了前两种说法，认为应以尺脉沉取为根。这个问题到目前为止尚无统一说法。如果说尺脉主肾，为先天之本，以尺为根（即以肾为根）是有一定道理的；然而事实上不会发生寸、关部有脉，尺部无脉和寸、关部无脉，尺部有脉的情况存在。寸、关、尺三部脉强弱不同的情况是存在的，但不应和有无相混，有根无根并非指的强弱，而是指的有无。如系指的强弱，一般正常人尺脉都弱，那么便可以把许多正常人的脉都认为无根和不恰当的，因为有根与否是预示着疾病预后的问题。假如以沉为根，浮脉类属于无根也不恰当。我认为仍应和脉的胃、神一样，以脉的节律、缓和、充实、有力为根较恰当。

3. 四时脉及四塞脉

四时脉象因四时季节及气候的不同，略有差异。春季脉稍弦，夏季脉稍洪，秋季脉稍浮，冬季脉稍沉。即春弦、夏钩、秋毛、冬石。四时脉来源于人和自然环境相适应的原理。也和五行配合四季及五脏的道理有关。春季万物始生，生机向上，阳气初升，在五脏配合肝脏，故当为弦。此弦当不失柔和之气，非病态之弦，如《素问·玉机真脏论》说：“其气来奭弱轻虚以滑，端直以长。”夏季万物盛长，暑热正盛，五脏配以心，故其脉当洪（即钩）。秋季渐凉，盛热已去，万物收成，五脏配以肺，肺主皮毛，其脉当浮（即毛）。冬季寒冷，万物收藏于里，五脏配以肾，故其脉当沉（即石）。四时脉虽应该应时出现，但不应该时至而该脉突止，必须向下一季延续一定时期。否则时至而上季脉突止

则称之为四塞脉。《素问·至真要大论》说：“春不沉、夏不弦、冬不涩，秋不数是谓四塞脉。”这段的意思是春季应有一段时间延续冬季的沉脉；夏季应有一段时间延续春季的弦脉；秋季应有一段时间延续夏季的数脉；冬季应有一段时间延续秋季的涩脉才是正常脉象，否则便是早绝其母气、五脏不相贯通的四塞脉。但应说明的是这里的四时脉是夏数秋涩，而不是夏洪秋浮。洪和数在性质上有相似之处，可以互通，然而浮和涩却不相同。涩肯定为病脉，以其作为四时之常脉似无道理，仍应以浮为是。因季节和气候的不同使人的脉搏稍有差异，在实际中是存在的，但这种变化不一定完全按上述规律一成不变。

4. 五 脏 脉

根据文献记载，五脏各有自己的正常脉象、病脉、死脉。如《四诊抉微》说：“心脉浮大而散……肺脉浮涩而短，……肝脉弦而长，……脾脉缓而大，……肾脉沉而软滑，……。”这是说五脏之平脉。该书对这段文字的解释是：“持脉如六菽重，按至血脉而得者为浮，稍加力脉道粗者为大，又稍加力脉道阔者为散。”以上是对心平脉中之浮、大和散的解释。此按至血脉系指诊脉之重力应在皮下肉上之部位，此部位为心之部位。此处之大和散不能理解为大脉和散脉，而应作形容词解。根据这段文字的记载，浮、大、散三种性状的脉是在三种用力程度上而得。也就是说心之常脉可在浮、中、沉（举、寻、按）三种不同情况下诊得。在不同的用力程度上，正常心脉的性状是不同的，此外

《素问·平人氣象论》中又说：“平心脉来，累累如连珠，如循琅玕曰心平。”其意思是诊得心之平脉应如连串的珠子从指下通过一样。这和以前所说心之平脉并不一样。其它脏的平脉说法也不统一，在这里我们不能轻信某家学说，需进一步探讨。

五脏病脉即指真脏脉。也有人认为真脏脉是指五脏的败坏，病情严重。另外又有五脏死脉，是指五脏完全停止功能活动的意思，也指见此脉预示着人的死亡。可见真脏脉和死脉都是预示病情严重的脉。兹将真脏脉和死脉列下表以作对比：

真脏脉与死脉比较表

	死脏（平人氣象论）	真脏脉（王机真脏论）
心	前曲后居，如操带钩。曰心死。	坚而搏，如循薏苡子累累然。
肝	急益劲如新张弓弦。曰肝死。	中外急如循刀刃，责责然如按琴瑟弦。
脾	锐尖如鸟之喙，如鸟之距如屋之漏，如水之流，曰脾死。	弱而乍数乍疏。
肺	如物之浮，如风吹毛，曰肺死。	大而虚，如以毛羽中人肤。
肾	发如夺索，辟辟如弹石，曰肾死。	搏而绝，如指弹石劈劈然。

五脏死脉及真脏脉的意义基本相同。但从脉的性状描述上看，除肝、肺、肾三脏的死脉和真脏脉有相同之处外，脾和心的死脉和真脏脉的性质有不同。我们认为五脏死脉和真脏脉预示着病情危重，气机衰微，但不能认为见到此脉必死而放弃治疗。

5. 脉的分类和纲脉

历代医家对脉象的种类提出很多不同意见，由16种到32种不等，但其中有许多脉象是相类似的，或者说是无法区分的。所以也有许多医家试图将众多脉象按其各自的特点不同归纳成为几类，以便执简驭繁，易于掌握。这些归类方法也不下数十种。（可参阅崔玉田的《中医脉学研究》36、37页，这里不占篇幅。）过去的这些分类方法各有特点，但都不能密切结合临床实际。目前较通行的是《中医诊断学讲义》第二版的分类方法，即以浮、沉、迟、数、虚、实为纲脉，把其余各脉归为此六类之中。浮脉类包括洪、芤、革、濡、弦；沉脉类包括有伏、牢；迟脉类包括缓、涩、结、代；数脉类包括促、动、紧、疾；虚脉类包括散、细、短、弱、微；实脉类包括长、滑。但这种分法不能充分突出脉象特征，且每类脉象的临床意义又不大相关，所以我们建议应从脉搏的性状实质和临床意义进行分类。具体方法如下：说明脉搏速率的脉，数、动、疾、迟、缓；说明脉搏节律的脉，促、结、代、散；说明血液粘稠度的脉，滑、涩；说明血管于人体解剖深浅部位的脉，浮、沉、伏、牢；说明血管壁弹性和血管张力的脉，弦、紧、革、芤、濡、弱；说明血管充盈度和搏动力的脉，洪、细、濡、弱、微、芤、革、虚、实、长、短。

这种归类方法明确突出脉象的特征，易于掌握，并能密切结合临床应用。

6. 脉诊和预后

根据历代医籍的记载，诊脉的预后可以分为两类：一类

是顺逆；另一类是决死生。所谓顺，是指有是症而有是脉，脉症相应，预示疾病是按正常规律发展。所谓逆，是指脉症不相应，预示疾病不按正常规律发展。如《素问·平人氣象论》说：“脉从阴阳病易已，脉逆阴阳病难已。”所谓脉从阴阳即指脉症相符，阳症有阳脉，阴症有阴脉。病容易痊愈。脉逆阴阳者恰与此相反。然而此条在“约注”下却有这样解释：“凡外感症阳病见阳脉为顺，阳病见阴脉为逆，阴病见阳脉也为顺。内伤症阳病见阳脉为顺，阳病见阴脉为逆，阴病见阴脉为顺，阴病见阳脉为逆。”又如在仲景的《伤寒论》中说：“伤寒阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死。”前后两者都有阴病见阳脉者生，为顺的说法。阴病见阳脉是脉症不符，脉逆阴阳，然而却是顺症，预后良好，和“脉逆阴阳病难已”相矛盾。可能是前者言其一般规律，后者言其特殊规律。但在一般的情况下脉应是从阴阳为好。然而有时脉逆阴阳亦为顺。这种情况只能限于阴病见阳脉，阳症见阴脉是不行的。原因可能在于阴主衰弱，阳主生机旺盛。阴症见阳脉尚有生机，阳症见阴脉则无生机。

张璐认为阴脉和阳脉，应以仲景的：浮、大、动、数、滑为阳，沉、涩、弱、弦、微为阴说法为总纲“（具体每部脉的阴阳可依《濒湖脉学》为准）。

还应强调说明的是在上述“约注”一条中，同是阴病见阳脉，在外感病则为顺，在内伤病则为逆。外感病之阴症多系感受寒邪，见阳脉说明阳气鼓舞能够抗邪，预示疾病向全愈方面发展是有道理的。内伤病的阴病见阳脉为逆的道理是因其符合脉逆阴阳的一般规律。

《灵枢·王版篇》尚载有五逆：“腹胀身热脉大是一逆也。腹鸣而满，四肢清冷泄，其脉大是二逆也。衄而不止脉大是三逆也。咳且洩血脱形其脉小劲是四逆也。欬脱形身热脉小以疾是谓五逆也。如是者不过十五日而死矣。”紧接此文又有一个五逆：“其腹大胀四末清，脱形泄甚是一逆也。腹胀便血其脉大时绝是二逆。欬上洩血形肉脱，脉搏是三逆也。呕血胸满引背脉小而疾是四逆也。咳呕腹胀，且殄泄其脉绝是五逆也。如是者不及一时而死矣。”

《灵枢·五禁篇》又有一个五逆：“身热脉静，汗已出脉盛躁是一逆也。病泄脉洪大是二逆也。淫而夺形身热色天然白及后下血衄重笃是四逆。寒热夺形脉坚搏是谓五逆也。”这里接连提出三个五逆，共十五逆症。逆症和重症有区别，重症是脉症相合，逆症是脉症相反。

另一类为通过诊脉可以断定死期。如《脉经》说：“一动一止二日死。二动一止三日死。……十动一止立夏死。”又说：“不满五十动一止者五岁死。四十动而一止者一脏无气，四岁死。……十动而一止者四脏无气，岁中死。”从现代医学的观点出发，引起脉搏时有休止的原因很多，诸如早搏、房颤、Ⅱ度房室传导阻滞、窦房传导阻滞、窦性停搏等都可造成脉搏时有停止。其中造成脉搏这样有规律性停止的最多见的还是早搏。早搏有很大一部分不是器质性病变的表现，当然更谈不上几日死了。一般窦性心动过速引起的水与电解质紊乱、低血钾症等，常可引起二联律（二动一停），尤其儿童更为显见。笔者曾遇到一例四岁儿童因消化不良，低血钾引起的二联律，经补钾后二联律即刻消失。当然某些器质性

心脏病也可以发生早搏或脉搏休止，但即或如此也不能就断定几日死，除非有RonT现象时易发生室颤而死亡。所以脉搏的休止现象有重病有轻病、还可为无病。所以要判断其预后最好要结合现代医学诊断弄清其发生原因，这样判断才能比较准确。当然对古代对预后的判断方法，我们应历史的看问题。

总之，诊脉对疾病的预后的判断有一定参考意义，但不能象上述经文说的那样绝对和肯定。这个问题仍须我们今后进一步进行探讨和研究。

7. 关于正常脉象

所谓正常脉象是指正常人非病态的脉象。历来各家对正常脉象说法也很不统一。自《脉经》始，把缓脉叫做平脉（即正常脉），但某些脉学书籍认为缓脉也是病脉。在一些脉学书籍中认为正常脉必须具备有胃、神、根的特点。近来的中医院校教材中认为平脉应具有缓和有力、从容有节、不快不慢的特点。这些特点和胃、神、根的特点基本一样。并认为其应随年龄、性别、体质、精神状态和季节的不同而异。但是，以上所说的正常脉象从资料来源看并非来自对大量正人（无病人）的调查和统计的结果。所以它不能代表大多数正常人的脉象。这种正常脉象在某种程度上带有主观规定、作文或描写的特点，并非完全来自客观实践，所以有方法上的错误。这种正常脉象只能代表一少部分人的正常脉象，而忽略了许多因个体差异而呈现的正常而无病的脉象，所以我们认为只有从广大正常人（无病人）群中调查统计而来的脉象才能真正代表正常人的脉象。为此我们在黑龙江中医学

院七七级学员中选择87名健康者作了脉象调查和分析，企图了解一下“正常脉象”的范围和规律。

共87人。其中男48人，女39人。年龄从18岁到24岁。该87例中所出现的脉象见下表：

87例正常人脉象调查表

脉 象	沉	缓	滑	细	弱	弦	数	实	浮	大
例 数	49	23	15	10	10	6	5	3	2	1
%	56.3	26.2	17.2	11.5	11.5	6.7	5.7	3.4	2.3	1.1

因脉象有互兼，故总例数超过87例。该87例皆无既往病史，现在无任何不适感；一般查体无异常所见。这十种脉象如按过去文献判定都属病脉，然而却都在健康人身上表现出来，这是值得探讨的问题。这些脉虽然过去都被定为病脉，然而和某些疾病不见得都有必然联系，有些脉（尤其象沉、缓、滑、细、弱等脉）完全可以在正常人中出现。沉脉可能只是血管解剖部位的深在，或者是由于皮下脂肪和肌肉丰厚的结果；缓脉本来就是正常脉象的表示；出现滑脉的机制多半是正常的生理机制；细脉主要是由于血管形态上的细小；弱脉多兼沉象，于正常健康女性很多见。这些脉很难说它们就是病脉，它们的病理意义到底多大，只有经过大量的调查统计工作后，才能肯定。尽管我们现在不能就肯定它是正常脉象，但也不能就肯定它是由病理原因造成的。这里应提出的是，在继承和整理中医理论时应注意方法，对自然科学用自然科学的方法去研究，而不能用作文式的方法去研究。

七、病 脉

病脉是病理现象所致的脉象。尽管过去文献记载的病脉现在看来不完全是病脉，这里仍按过去文献记载的病脉加以介绍。关于病脉的种类，历代医家记载的很不统一。明·张介宾的《景岳全书》中记载的病脉最少，只有16种；清·张璐的《诊宗三昧》记载的病脉最多，有32种；目前最通用的是明·李时珍的《濒湖脉学》中的27种。

这里基本以这27种脉为例加以介绍。其中有些脉象很类似或相同的，这里加以归类或在主要脉象中附带介绍。对各脉的出现机制适当地运用现代医学理论进行了解释，各脉的主病密切结合了临床实践，以便使脉学更能理论结合实践和指导实践。

1. 浮 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说浮脉的脉象是“举之有余，按之不足，如微风吹鸟背上毛……，如水漂木。”这是李濒湖引用《素问》、《脉经》等多种典籍的综合结论。总之，浮脉的脉象应是轻取即得，即手指轻轻接触皮肤便可摸到最明显的脉搏搏动，重按反而不明显。

浮脉一般在关部和寸部表现的较为明显，尺部一般绝少见。而且左右手可以表现的不一样，可以有一手是浮脉，而另一手却不浮。

浮脉只是言其脉搏的深浅部位，而不兼具其它脉象概念。如同时兼有其它脉象的特点，则叫相兼脉，其临床意义又有所改变。

〔机制〕

浮脉标志脉管解剖部位的表浅。造成这种现象的原因是肌肉消瘦、皮下脂肪少，至使血管直接处于皮下而表浅，使诊脉时轻取可得。此种浮脉不属病理现象。另外，是因各种原因（病理和生理的）使血管扩张、血流加速、脉搏搏动有力。在这种情况下因血管的基部比较固定，所以血管主要是向外（表浅）扩张，故在诊脉时可以触到脉搏的表浅（浮）。但这种血管的扩张同时也向周围扩张，所以严格的说这种脉象不仅呈浮，而且具有粗大、有力的特征。这类浮脉不但浮取明显，沉取或中取也很明显。

〔临床意义〕

（1）可见于较瘦，皮下脂肪少的正常人。

（2）可见于因久病，正气衰弱和心气虚极之人。因疾病的消耗而致消瘦者。因皮下脂肪少，也可以呈浮脉，但其必兼无力。传统的脉学书籍的浮主里虚和血虚之说，即是此义。

（3）可见于外感热性病的初期（表证）。由于发热，心搏有力，血流加速，和血管扩张可有轻取即得的浮脉。但这种浮脉除轻取外，中取和沉取也往往明显而有力。

但浮脉与表证之间并非有必然联系，即表证可以有浮脉，但表证不一定都呈浮脉，浮脉也不都见于表证，并且浮脉以热症、实症为多，虚寒症为少。我们统计了200例住院病人的脉象，其中浮脉有5例，其中有荨麻疹一例、大叶性肺炎一例、结核性脑膜炎一例，（辨证属里症）上呼吸道感染一例、化脓性扁桃体炎一例。（辨证属表症）。

上述疾病都属中医辨证的热症、实证范围。5例中仅2例属表症，其余3例皆属里症。

如浮脉兼有其它脉象，这时的主病就各不一样。如《四诊抉微》中说：“……浮芤失血，浮洪虚热，浮散劳极，浮涩伤血，浮濡阴虚，浮短气病，浮弦痰饮，浮滑痰热，浮数不热疮疽之征。”这些不同的主病主要是因兼脉而异。

2. 沉脉（附：伏脉）

〔脉象〕

《中医学基础》载：“轻取不应，重按乃得。特点是脉象部位深在。”所以我们综合沉脉的脉象便是轻取不显重按乃得，举之不足按之有余。即沉脉在诊脉时用力重取血管搏动显得有力或搏动最明显，轻取则血管搏动不明显或摸不到。

沉脉在寸关尺三部都可以诊得，但以尺部诊得者为最多见。沉脉左右手也可以呈一手沉、一手不沉，亦可双手皆沉。

沉脉很少单独出现，往往是以相兼脉的形式出现。

沉脉的诊取方法是较为用力，但不达筋骨。推筋着骨所取到的脉搏则为伏脉。

〔机制〕

肌肉和皮下脂肪较厚，血管解剖位置较深在，或者比较细，血管搏动弱，故呈沉脉。这种情况属于正常生理性沉脉。另外，由于久病致使循环系统功能低下，使血管搏动较弱，也可呈沉脉，这种情况则属病理现象，其沉脉兼细弱无力者居多。

〔临床意义〕

（1）可见于正常人。尤其肌肉较丰厚和皮下脂肪较多的青壮年女性呈沉脉者更为多见。何梦瑶所说：“肥人多沉”即是此义。我们见到的47例健康学员的沉脉中，有30例是女性，占沉脉总例数的64%。也说明了这一点。

《三指禅》说：“有病而沉兼别脉，沉而无病世人多。”“有病而沉兼别脉”，即病态而有沉脉的，其病多在沉脉的兼脉中体现出来，而和沉脉本身多无大关系。所以又说：“沉而无病世人多”。

（2）可见于里证。沉而有力为里实，沉而无力为里虚。此种沉脉常兼有细弱无力的特点。如较为严重的亡血和脱津，可以使血容量不足，循环系统机能不佳，血管搏动无力而表现为沉脉。

某些里实证正气未衰者表现为沉而有力之脉象，这类沉脉多兼洪大，诊脉时，浮、中取亦可得。

我们统计的200例住院病人的脉象中有沉象者47例，其中男性17例，女性30例。这47例中的中医诊断有：泻泄，腹胀，热淋，痹证，肺热咳嗽，胸痹，胃脘痛，肝阳上亢，心痹、虚劳、水肿、消渴、胁痛等；西医诊断有冠心病，高血

压动脉硬化，风湿性心脏病，结肠炎，肝硬化性腹水，胃、十二指肠溃疡，胃癌，慢性肝炎，急性胃肠炎，菌痢，结核性腹膜炎，肺感染，肺结核，支气管扩张，尿路感染，风湿性节关节炎，再生障碍性贫血，糖尿病，淋巴腺结核，神经性呕吐，尿毒症等。以上疾病都属中医里证范围。

附：伏 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“诊察伏脉，必须用力重按着骨，指下才能感觉到脉搏的搏动……。”《脉经·脉形指下秘诀》说：“伏脉极重，按之着骨仍得。”《诊家正眼》说：“伏为隐伏，更下于沉；推筋着骨，始得其形。”以上都说明伏脉和沉脉有程度上的不同。伏脉多兼微弱无力的特点，所以多属病理现象。

〔机制〕

基本同沉脉。

〔临床意义〕

伏脉一般很少见于正常人。伏脉常见于阴症、寒症和虚症。

3. 迟 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“迟脉一息三至，去来极慢。”故迟脉是指脉率缓慢。如以每分钟呼吸按20次计，一息三至相当于每分钟脉率在60次左右。过去也曾有人建议以脉率每分钟

60次以下的脉为迟脉，这个标准是有道理的，和现代医学有默契之处。

迟脉在两手各部应该是一致的。迟脉还可以兼有其它脉象而成复合脉。

迟脉应和缓脉相区别，缓脉系言脉来缓和而脉率是在正常范围之内。

〔机制〕

《中医学基础》第二版解释为“寒则气收，凝滞脉道，阳失健运，故脉行迟缓。”然而脉道凝滞不通只能使血流涩滞不畅致成涩脉，不会引起脉率的改变。

脉率决定于心搏次数，故凡可影响心搏次数的因素都可以影响脉率。一般来说，热症可使心率加快，虚证和寒证可使心率减慢。

从心电图上看，心率每分钟低于60次者常见的有窦性心动过缓，二度以上房室传导阻滞，双束枝传导阻滞等。其主要原因是各种原因引起的心脏自律性异常或激动传导障碍。用于治疗心率过慢的药物主要是拟交感神经药物和糖类激素，根据上海第一医学院脏象研究组的研究，肾阳虚的病理改变恰是和上述药物性质相同的物质缺乏，所以心率过慢的原因可能和肾阳虚有关。

〔临床意义〕

（1）除个别训练有素的运动员在静息时脉率可低于每分钟60次外，迟脉一般不见于健康人。

（2）在中医八纲辨证方面多见于阳虚证和寒证，如心阳虚，肾阳虚等，其中医诊断有真心痛、心痹、热痹、外感

温毒之邪内舍于心等证；西医诊断有冠心病，心肌炎、心肌病、风湿性心脏炎、风湿性心脏瓣膜病、心肌变性疾病、先天性心脏病、克山病等。此外也可见于麻醉、乏氧、体温过低、酸中毒、高血钾和某些药物过量（如洋地黄、奎尼丁、心得安、普鲁卡因酰胺等）。

我们统计的 200 例住院病人的脉象中，只有一例迟脉。其中医诊断是：真心痛（心血瘀阻型）；西医诊断是冠心病三度房室传导阻滞。

4. 数、动 脉

〔脉象〕

数脉是指脉率一息六至以上。相当于每分钟脉搏在 100 次以上。另外数脉尚有去来流利薄疾的特点。

动脉必须具有数脉的特点。李时珍说：“动脉摇摇数在关，无头无尾豆形圆”意思是动脉只表现在关部。但有人不同意这种说法，如《濒湖脉学白话解》、《脉诊选要》、《中医脉学研究》等都认为动脉不应只是关部，而应是寸、关、尺三部都见数脉。只不过是关部脉搏动明显，寸部、尺部脉搏动稍弱些，但一般脉象都具有这个特点。这样看动脉和数脉并没有明显的区别，故可以合并在一起，勿需单立名目。

〔机制〕

凡可引起心脏自律性异常或激动传导障碍，均可引起心动过速。另外，心脏的生理功能受神经—体液因素调节，大脑皮质通过植物神经系统实现其对心脏功能的调节。交感神经兴奋时，儿茶酚胺的释放增多，使窦房结自律性增高，心

率加快，心搏增强，激动传导速度加快及不应期缩短。临床上常见的能够引起心搏次数增加的原因，主要有以下几种：

（1）发热。发热时产能增加，代谢加快，故有反射性的心搏加快。

（2）机能亢进。如甲亢（中医属心阴虚火旺）可通过其过多的甲状腺和交感神经的兴奋作用使心跳加快。

（3）代偿。当心脏机能衰弱时（心气虚），心脏的排血功能减退，心脏每搏输出量减少，为维持机体生理需要，就须增加心搏次数以代偿每搏输出量的不足，而引起心搏加快。

（4）起搏点（包括窦房结和异位起搏点）的兴奋性增高引起心搏加快。

（5）交感神经兴奋性增高和拟交感神经的药物使用，通过神经、体液的调节作用，引起心搏的加快。

〔临床意义〕

（1）可见于正常人体力活动、情绪激动、吸烟、饮酒、喝浓茶或咖啡时。

（2）服用某些药物（如麻黄素、阿托品、异丙肾上腺素等）。

（3）可见于热证。外感六淫之邪或温热之邪袭表或已入里，因其发热，皆可见数脉。

（4）可见于阴虚火旺之证（如消渴等证）。

（5）可见于心阳虚、心阳暴脱、水气凌心、心气虚极的虚症。

我们统计的 200 例住院病人脉象中属数脉者有 56 例，中

医诊断有：湿热下痢，热淋、热痹、肺热喘咳、眩晕、哮喘、肺阴虚咳嗽、虚劳、中风、消渴、黄疸、膨胀等，多是热症和阴虚火旺症。

5. 疾 脉

〔脉象〕

疾脉属数脉类，但和数脉不同。《诊家正眼》说：“疾为急疾，数之至极，七至八至，脉流薄疾。”《脉诊选要》引《诊家枢要》说：“快于数而疾，呼吸之间脉七至，热极之脉也。”《素问·大奇论》说：“脉至如数，使人暴惊，三四日自己，脉至浮合，浮合如数，一息十至以上，是经气予不足也，微见九十日死。”此有言七至，有言十至。如以一息八、九至计算，相当于每分钟脉搏在160次以上。由此可见脉搏每分钟100~160次为数脉，160次以上则为疾脉。这恰恰是窦性心动过速和阵发性心动过速的分界线，和现代医学的分法也相吻合。

〔机制〕

疾脉的发生机制和数脉不一样。疾脉是由于心脏的异位搏动过速引起的。其主要为阵发性心动过速，心房扑动伴有室率过快。它们都是由于异位起搏点兴奋性增高引起，多半和发热本身以及心脏代偿性加速等因素无关。这种异位起搏点兴奋性增高的电生理机制至今还不清楚。

〔临床意义〕

一般说来，疾脉和数脉不同，它和发热没大关系。所以有人主张疾脉主热极是不对的。除少数病人是由于兴奋、激

动、疲乏，饮食等因素诱起发作外，一般都是由各种原因的心脏病引起。常见的中医诊断有真心痛、支饮、热痹、心痹、眩晕、心悸等。西医诊断有冠心病、肺心病、高血压性心脏病、风湿性心脏病、甲状腺机能亢进等。

过去认为疾脉见于危重症候，其实有时见疾脉者证候不见得危重。疾脉有时亦可以自行停止。如《素问，大奇论》说：“脉至如数，使人暴惊，三四日自己……。”从临床看不但三四日可自己，几小时或更短时间也可自己，所以看疾脉的预后如何，要以引起疾脉的原因而定。

6. 虚脉（附：芤脉）

〔脉象〕

《脉经》说：“虚脉迟大而软，按之不足。隐指豁然空。”迟大之迟是指血流迟缓不畅而言，并非指缓慢。大者指血管粗大。按之不足的按字是指诊脉动作而言，而不是指举、按、寻之按。按之不足系指血管不充实、按之中空。《中医学基础》第二版中说，“三部举、按皆无力。”即指该脉浮、中、沉取都无力。根据以上说法，虚脉应具备无论哪一部哪一候脉来都是虚弱无力的，脉搏粗大，脉软（血管不充实，按之有中空感觉）的特点。所以虚脉和一般的无力脉是有区别的。

〔机制〕

脉搏无力主要是由心搏无力所致。脉大是由于血管粗大和血管舒张造成的。脉软是指血管壁没有硬化，弹性尚好。脉中空是血管充盈不足，血容量不足的特点。中医理论认为

其主要由气虚、血虚、脱津引起。

同样一个心搏力弱，搏血量少，血容量低的病理过程，如发生在血管粗大而血管壁较软的病人，则表现为虚脉；发生在血管粗大而血管壁较硬的病人则为芤脉；发生在脉管细小而软的病人则为软脉（濡弱脉）。

〔临床意义〕

（1）可见于气虚证。心气虚，心搏力弱，心脏搏出血量少，脉搏则无力而弱。如各种原因的心脏病，最后导致心气虚、水气凌心而引起心悸气短、动则尤甚，不能平卧，水肿等症状时常有此脉。

（2）可见于脱证。各种原因引起的脱血及汗、吐、泻而导致的脱津。此两者都可以引起血容量减少，使血管充盈不足而使脉来中空无力。

附：芤 脉

〔脉象〕

浮大中空，按之中间无力而边硬。浮是指浮取而得此脉，中空是指脉来不充实、血管壁较硬。

〔机制〕

〔临床意义〕

基本上与虚脉相同。只是兼有血管壁硬化及血容量减少。

7. 实 脉

〔脉象〕

《脉经》说：“实脉大而长，微强，按之隐指幅幅然”。

《诊家正眼》中说：“实脉有力，长大而坚应指幅幅，三候皆然。”《濒湖脉学》说：“浮沉皆得大而长，应指无虚幅幅强。”其它书籍的记载也大致相同。总的看，实脉应具有脉搏长（超过一般的脉，而且粗大，属于长大脉之类），脉搏搏动有力。而且这种强而有力的脉象，无论浮、中、沉任何一候皆相同。其实任何一种脉象在浮、中、沉三候中都不可能是一致的（即浮、中、沉三候的脉搏有力程度不可能相同）。所以，笔者建议对实脉的概念只强调其粗大有力，而不在浮、中、沉三候上加以限定。

〔机制〕

实脉的血管粗大是由于局部的血管形态粗大，或血管扩张，血管充盈度增加引起。血管充盈良好的条件是因血容量充足、心脏每搏搏出血量大等因素为前提。脉搏有力也是心搏有力，血容量充足，心脏每搏搏出血量多的结果。以上现象可因体质壮实或因兴奋、焦虑等因素引起，中医理论认为其主要是由于气血俱盛、心气旺盛、血运有力等因素所致。

〔临床意义〕

（1）可见于正常人。可因体格壮实或因兴奋饮酒、喝浓茶后而见实脉。

（2）可见于实热证。外感热病，无论在表阶段或在里阶段都可以见实脉。这主要是由于发热所致。其中以里实热证见实脉者为最多。

（3）可见于实证。如症瘕积聚、血瘀等实证在正气未虚时皆可实脉，但一般正虚邪实之疾病多不出现实脉。

（4）服用某些药物（如人参、附子等）之后。

8. 滑 脉

〔脉象〕

《诊家正眼》说：“滑脉替替，往来流利，盘珠之形，荷露之义。”《洄溪脉学》说：“滑脉应指替替然，往来之势，流利圆活，如盘中走珠，如荷叶承露。”《脉诊选要》说：“是为滑脉之形容，亦为营卫充实之现象。”

总的看来，滑脉的特点应是滑利迅速，波峰如珠圆，故诊脉时有珠子迅速从手下滑过的感觉。

滑脉主要以关部表现最为明显，其次为寸，尺部则不太明显，这是寸口脉的共同特点。滑脉两手可有不同，可见一手呈滑象，另一手不呈滑象的现象。

〔机制〕

脉搏滑利必须具有血管内膜光滑，心脏搏动有力，血容量充足，血液粘稠度小和血管壁富有弹性的特点，即具备“波形脉”的特点。所谓“波形脉”是指脉管运动（舒缩）成波浪状，波幅大。

〔临床意义〕

（1）可见于健康的正常人。如《脉义简摩》说：“男子得此无病，女子得此有胎。”即为此义。

（2）可见于由湿邪引起的病证。在我们统计的93例呈滑脉的病例中，中医诊断有膨胀，饮证、水肿等证；西医诊断有肝硬化性腹水、胸腔积液、慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺源性心脏病等。这些疾病都属于中医水湿内停，湿邪为患范围。

(3) 可见于热证，在我们统计的 93 例呈滑脉的病例中，中医诊断有消渴、眩晕、肺炎、痢疾等证；西医诊断有糖尿病、肺炎球菌性肺炎、细菌性痢疾等疾病。这些疾病都属于中医热证范围。

(4) 可见于湿热互结证。在我们统计的 93 例呈滑脉的病例中，中医诊断有黄疸、腹痛、石淋、痹证、哮喘、喘证、虚劳等证；西医诊断有黄疸性肝炎、胆囊炎、尿路结石、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、胶原性疾病、心肌炎、哮喘、肝硬化癌变、结核病、白血病等疾病。这些疾病中医辨证大部分属于湿热范围或偏于湿热者。

9. 涩 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“涩脉，细而迟，往来难，短且散，或一止复来。参伍不调”。《诊家正眼》说：“涩脉蹇滞，如刀刮竹；迟细而短，三象俱足。”据以上记载涩脉的特点应是血流滞涩不畅伴有节律不整或脉来迟慢。《脉诊选要》说：“按迟，非迟数之谓，乃言其迟钝不前之意，故又曰‘往来难具散’；因其往来不爽，有时或似停顿，故曰：‘或一止复来’。但不能和有歇止之结代二脉相提并论。”由此可见涩脉不应有歇止和脉来迟慢的特点，而应以血流滞涩不畅、脉来迟缓的说法较为合适。

〔机制〕

脉来涩滞不畅可因血管内膜不光滑（包括血管内膜的粥样硬化和内膜的炎症）；心搏无力，排血量少；血液浓缩或

粘稠度增加（红细胞数绝对和相对增加以及水分的丢失）而引起。心搏无力和排血量少是次要条件，如没有其余两项条件只能产生微脉和弱脉，而不出现涩脉。

〔临床意义〕

（1）可见于津液亏耗之证。如汗、吐、泻；热病过久耗伤阴津；长期进水量不足等，均可引起血中之水分亏乏，使血中之有形成分浓缩，血粘稠度增加，流动迟缓，发生涩脉。《诊家正眼》说：“涩为血少”。这里并非指血中所有成分都少，而只是指血中之水分缺少。《濒湖脉学》说：“反胃、亡阳、汗、雨淋。”即说明由吐、汗、泻泄引起的津液亏耗等因素可引起此脉。

（2）可见于因脉道滞涩，血流不畅，经络不通而引起的诸证。脉道涩滞、血流不畅、而引起的疼痛即为“不通则痛”。如《素问·脉要精微论》说：“涩则心痛”即是此意。又如肢体末端疼痛、变色，最后溃烂脱落之脱骨疽，亦属经络不通之病变，在该病变之肢体局部也可见此脉。脉道的涩滞不畅，发生在不同部位可表现为不同部位的疼痛。所以涩脉有一定的局部诊断意义。

（3）据《金匱要略》载：亡精、遗精及房劳过度可见涩脉。另据《脉义简摩》说：涩脉多预示着疾病病程较长和病情较重。

10. 弦 脉

〔脉象〕

《素问》说：“端直以长。”《脉经》说：“如按弓弦。”

《诊家正眼》说：“弦如琴弦，轻虚而滑；端直以长，指下挺然。”其它书籍的记载也基本和此相同。所谓端直以长即指血管由头至尾，其粗细、张力和搏动力一致，且脉来紧张绷急而有力。弦脉可见两手皆弦，也可见单一手弦；亦可以分别表现在浮、中、沉任一候中。

〔机制〕

弦脉的形成主要由心搏有力，搏出血量多，血管充盈度高；脉管壁紧张、收缩。心搏有力可以由于各种原因反射性地引起的心脏收缩力增强。血管壁紧张收缩主要由交感神经兴奋性增高引起。交感神经兴奋性增高和中医的肝郁气滞有密切关系，和肝阳偏亢也有一定关系。这也是弦脉最多见于肝郁气滞和肝阳偏亢（高血压）的原因。

〔临床意义〕

（1）可见于肝阳偏亢引起诸证。如头痛头晕，耳鸣，面赤，肢麻、多梦、失眠，健忘等症均可见弦脉，这些症状都和高血压有一定关系。根据中医研究院的统计，高血压有97%为弦脉。

（2）可见于肝郁气滞引起诸证。因情志因素，如思虑、忧郁、惊怒等引起的肝气不舒；肝郁气滞者可见弦脉。

（3）可见于肝郁气滞引起的血瘀。血瘀则可以发生积聚之类病变，其病变初期也可见弦脉。

在我们总结的200例住院病人脉象中，有弦象者108例，男与女的比例为2.5:1；年龄组以40—50岁者最多。

在此108例中，中医诊断有胃脘痛、腹痛、鼓胀、胁痛等证，这些病证都和肝郁气滞、肝胃不和有关；另外还有眩

晕、头痛等，此类证型多为肝肾阴虚，肝阳偏亢；较为少见的病证有痰饮、水肿、中风、哮喘；此外更为散见的还有淋证、痢疾、虚劳、痹症、泻泄、胸痹、心悸、怔忡、血证等证。西医诊断有高血压、泌尿系结石、动脉硬化、脑血管意外、消化性溃疡、急、慢性胃炎、慢性肝炎、胆囊炎、肝硬化性腹水、肺心病心衰。以上统计表明弦脉主要集中表现在循环系统和消化系统疾病。

11. 长 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“长脉不大不小，迢迢自若，如循长竿末稍，为平；如引绳、如循长竿为病。”此言长脉有平、病两种。紧张而硬者为病，柔软而徐缓自若者为平。该书又说：“过于本位脉名长。”意思是长脉应超过原来的脉位，这里如何理解“本位”是个关键。本位应是三部合起来的本位，即以整个寸口脉为本位。亦即超过一寸九分。

〔机制〕

寸口脉的血管是上下连续不断的，所以也根本不存在什么长和短的问题。所谓长就是诊脉时寸部和尺部在指下感觉搏动很明显；短即寸和尺脉极沉弱，在指下感觉搏动不明显，只有关部搏动明显。决定寸部和尺部搏动是否明显取决于心搏力和血管充盈度（心搏有力，血管充盈度高则寸部和尺部也较明显，反之则否）；寸口脉局部的解剖结构（如寸口脉血管平直则呈长脉，反之则呈短脉）。

〔临床意义〕

如不兼其它脉象，长脉本身多为正常现象无病理意义。如《诊家正眼》说，“故知长而和缓，即春生之气，而为健旺之征。”《黄帝内经》说：“长则气治。”治即正常。也是指正常之象。李月池说，“心脉长者，神强气壮；肾脉长者蒂固根深，皆言平脉也。”即为此意。病理情况下出现的所谓长脉都是长脉兼有其它脉象，其实这时也不成为长脉了，如《诊家正眼》说：“长而硬满，即属火亢之形，而为疾病之应也。”此长而硬满则为大脉、实脉和弦脉之象，这种主病和长脉本身是无关系的。

据长脉出现的机制也属正常生理机制，非为病理现象，故说长脉为正常脉象是有道理的。

12. 短 脉

〔脉象〕

《诊家正眼》说：“短脉涩小，首尾俱俯；中间突起，不能满部。”又说：“短之为象，两头沉下，而中间独浮也。”《濒湖脉学白话解》说：“短脉与长脉相反，它在寸、尺部位，都表现为不满足，或者是寸部不满足，或者是尺部不满足。它的搏动也非常短暂，刚一应指，便立即回避开了。”以上皆说明短脉主要是对整个寸口脉三部而言，其表现为寸部和尺部脉搏不明显，独关部搏动明显。而并非寸口脉三部可以各见短脉。据《濒湖脉学白话解》的说法，短脉除具有形状的短而外，尚有每搏搏动时间上的短促。若以部位上的短小而言，两手可有不同。但若以时间上的短促而言，两手应相同。

〔机制〕

短脉和动脉相似，两端不清，似豆状表现在关部。此种情况可由血管两端深埋在肌肉和皮下组织深部，独关部血管较表浅而造成。这主要是由局部解剖构造的差异造成的。脉搏每搏搏动时间的短促和心室收缩期短有关。也和心室每搏排血量少有关，如房颤和早搏常出现此现象。这种脉搏就其波形来说也类似“波形脉”。短脉的血管张力相对来说不会高，血管壁硬度也不会大。以上几种机制，除心室每搏排血量少而外，都无病理意义。

〔临床意义〕

(1) 可见于气血虚衰诸证，一般而言短主不足，短脉就心脏每搏排血量少而言是血管的血液充盈不足造成的。在出现结脉和代脉时，歇止前的一次脉搏大多数是短脉。那么这时短脉的意义就和结、代脉是相同的。如中医诊断的心痹、真心痛等证。

(2) 情志为病，生活不节等也偶可引起本脉。

(3) 可偶见于正常人。如《诊家正眼》说：“短中自有和缓之象，气乃治也。”即为此义。

13. 洪 脉

〔脉象〕

《脉经》说：“洪脉，极大在指下。”《濒湖脉学白话解》说：“洪脉指下极大，来盛去衰，来大去长。”又说：“不仅来的时候显得势极充盛，即去的时候也是缓缓减弱的，要在较长的时间内才能消逝，这就叫做去衰。”《诊家

正眼》说：“洪脉极大，状如洪水；来盛去衰，滔滔满指。综上所述洪脉的特点是脉搏向上搏动时洪大有力的说法是比较统一的。但有说去衰，有说去长，这点是有所区别的。

《濒湖脉学白话解》认为脉搏缓缓减弱，要在较长时间内才能消失是去衰，其实这种解释莫如叫去长，这里是把去衰和去长混为一谈，其实这二者是完全不一样的。去衰是指脉的波形在下降时的血管充盈度、张力和压力突然衰减而呈陷落状。《中医脉学研究》说洪脉的去衰是因脉波在降落时动脉压力迅速下降而造成去衰。把洪脉比做“水冲脉”或“陷落脉”，这种说法比较合适。在脉搏描记器的描记图上的洪脉波形下降很迅速、呈尖峰状，而非下降缓慢，故《濒湖脉诀白话解》的上述解释显然是不合适的。动脉硬化化的洪脉在脉搏描记器的记录图上显示重搏波平坦。

〔机制〕

洪脉的来盛，如波涛汹涌，洪大有力，是由心搏有力、血管粗大，心脏的每搏排血量较多，血管充盈度较好等因素造成。脉搏的去衰、陷落是脉搏压力突然下降的结果。其原因主要由血液的回流、血管壁弹性减低造成的。血液回流是由于各种原因造成的主动脉瓣关闭不全；血管壁弹性降低主要是动脉硬化的结果。动脉硬化时，动脉弹性较小，当心脏舒张时，血管不能很快收缩。而表现为动脉压突然下降，成为“去衰”的洪脉。因为洪脉有去衰的特点，所以把洪脉和大脉、实脉、长脉等相提并论是不合适的。过去经常把实热证引起的洪大脉叫作洪脉，就是把洪大脉和洪脉混同了。洪大是形容词，然而洪脉则是专用名词。这里应该概念清楚。

〔临床意义〕

可见于中医诊断的心悸、心痹、中风等证。其辨证可有心阳虚、心气虚、血虚、血瘀、痰湿等症型；西医诊断有风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全、梅毒性主动脉炎和动脉硬化等疾病。

14. 微 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“微脉，极细而软，按之欲绝，若有若无。”《诊家正眼》说：“微脉极细，而又极软；似有若无，欲绝非绝。”张璐说：“微脉者似有似无，欲绝非绝，而按之稍有模糊之状，不似弱脉之小弱分明，细脉之纤细有力也。”这些说法有一点是相同的，即“软而无力，若有若无，似绝非绝。”另一点似有稍异，前两者说微脉应比细脉还细，而张璐认为微脉不似细脉之纤细有力。如以前者为准，则微脉的特点应是细小软而无力，这样濡、弱脉和细脉是难以区别的。至于细或更细只是程度上的区别，无法具体衡量。所以还是以张璐的说法较为合适。微脉的特点主要是微弱无力，似有似无，摸不清具体形状。而细、濡、弱之类虽也软而无力，但仍有细线状脉搏清楚可查，并且细脉血管还较有张力。

〔机制〕

微脉的产生是因心搏无力，搏血量少，或血容量少且血管舒张而血管壁较软，致使血管的充盈度较低。故诊脉时感觉脉来软而无力，似有似无。这种脉象主要见于周围循环衰竭时。

〔临床意义〕

(1) 可见于心气虚、心阳暴脱。各种原因引起的心脏病变，病情发展到危重阶段可致心气虚和心阳暴脱，这时心无力鼓舞血行，血不充于脉，则可产生微脉。

(2) 可见于脱血、脱津。各种原因的急性大脱血可造成血容量的不足，无以充盈血管产生微脉。

(3) 可见于热厥。在外感热病中，热邪入里，热邪壅盛并郁闭于里，不能达于外，产生四肢厥冷，神识不清等症，叫作热厥。此证也可出现微脉，如肺热壅盛、温热病的热入营血期等常可产生这种现象，这种疾病相当于西医诊断的感染性休克。

(4) 可见于各种长期危笃之疾病末期，阴阳绝离之时。临终之前出现微而欲绝之脉自不待说，另外尚有阳气欲脱时也可有微脉出现。

15. 细 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说，“细脉小于微而长有，细直而软，若丝线之应指。”又说：“细来累累细如丝，应指沉沉无绝期。”《诊家正眼》说：“细直而软，累累萦萦，状如丝线，较显于微。”又说：“细之为义，小也，状如丝也。……细脉则显明而易见，故细比于微稍稍较大也。”据以上说法，细脉主要特点是血管较细小，并具有一定的张力和弹性。但诊脉时，指下感觉清楚，这也是其不同于微、濡、弱脉之处。细比微大之说并不甚确切。细脉的特点是脉来细如丝而非大，

微脉的特点是脉搏形状不清楚，若自若无。如说微脉比细脉还细，就混淆了二者的区别。

〔机制〕

血管较细或收缩，血管壁张力和血管充盈尚好。血管细可为个体构造上的特点，也可为交感神经兴奋性增高，使血管收缩而致。而心搏力尚好和血容量尚较充足，所以血管的充盈度和张力尚好。

〔临床意义〕

（1）可见于正常人。如细脉是由桡动脉形态上的细小造成的，那便没有病理意义。我们统计了87例身体健康的学员的脉象中细脉有10例，占总例数的11%，其中女学员居多，说明有部分正常人可以表现为细脉。

（2）可因情志因素引起。精神紧张，思虑过度使交感神经兴奋性增高造成血管收缩可引起细脉。故推测细脉和弦脉可能有密切关系，将来有变成弦脉的可能。

（3）我们统计的200例住院病人的脉象中有细脉45例。其中男22例，女23例。中医诊断有胸痹、虚劳、腰痛、眩晕、喘证、黄疸、泻泄、胃脘痛、呕吐、热痹、饮证、胁痛、积聚、呕血、真心痛等证。这些病在性质和特点上无甚共同之处。另如《脉诊选要》载细脉主少气、血虚、泄利、湿痹、骨痛、腹满、胃痛、呕吐、疝瘕、冷积、怔忡。这些病种也似无内在联系。其中证候有虚有实，有气、血为病、脾胃病、筋骨病、神志病等。在这种情况下该脉的诊断意义就不大了。很多脉学书籍都说细脉主气血俱虚，但根据临床观察及统计，似乎细脉和气血虚弱不一定有必然关系。

我们观察细脉的西医病种分布也很分散，共计有26种疾病。这说明此脉和这些病种也并非有必然关系。

16. 软脉（濡脉、弱脉）

〔脉象〕

濡、弱二脉属于一类脉，故放在一起论述。各家脉学书籍皆言濡脉为极软而浮细，弱脉为极软而沉细。两者共同之处都是极软而细，所不同者是濡为浮取而得，弱脉沉取而得。濡、弱二脉可统称软脉，或者叫细软脉。无需叫两种脉名。如弦脉等都可以有浮沉之别，而不另立一名就是这个道理。

本脉和细脉的区别是前者血管壁较软，血管张力较低，细脉则恰恰相反。本脉和微脉的区别是微脉似有似无，形状不清；濡弱脉脉来虽也软，脉体较细，但脉体仍清楚可见，感知具体。微脉的血管非但不细，相反可以由于血管扩张而致稍粗。

〔机制〕

濡弱脉即软脉。是由血管细小和心脏收缩力弱，心排血量低产生的。血管细可由血管收缩造成，这种现象可使动脉的舒张压力增高；心搏力弱和心排血量低可由心力衰竭和心脏的舒张受限引起，如缩窄性心包炎和心包积液等疾病。此种情况可以使动脉血压的收缩压变低。前两种情况的结合可使脉压变小。心搏无力和心排血量少，血管充盈不足，可产生濡、弱脉。

〔临床意义〕

（1）可见于心气虚、心阳虚水气凌心时。血运功能减

低时，心的排血量少可使血管充盈不足，出现细软脉。病人可表现有心悸、气急，并可出现水肿和腹水。

(2) 可见于脱血和脱津。此时血容量减少，血管充盈不佳，可因血管的反射性收缩，而产生濡、弱脉。这种情况的延续，可产生阳气外脱的寒厥证，也可出现微脉。

(3) 可见于久病，机体衰弱，气血不足之证。

17. 紧 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“紧脉，往来有力，左右弹人手、如转索无常、数如切绳、如纫算线。”《诊家正眼》说：“紧脉有力，左右弹人，如绞转索，如切紧绳。”据以上说法紧脉应有血管紧张、绷急、张力高，血管壁硬如绳样，甚或有屈曲之特点。两手可以都呈紧脉，也可单表现为一侧。

紧脉和弦脉、芤脉、革脉的区别是弦脉无血管壁硬化及屈曲不平的特点；芤脉血管壁较硬血管充盈度较差；革脉类似芤脉。

〔机制〕

紧脉的血管壁张力较高，绷急是血管收缩，心搏有力，心排血量多，血管充盈度好之故。脉管硬而屈曲不平，弹人手，表明血管壁较硬和血管较屈曲。

紧脉在临床是较少见的脉象，即或在表寒证中也很少有此脉。过去许多被诊为紧脉的实际上是弦脉。有的人只把血管的紧张度高称为紧脉，而忽视了紧脉血管壁的硬度和屈曲，这样和弦脉便无法区别了。

〔临床意义〕

可见于寒证、血虚、血瘀、痰阻等证。紧脉表明血压高，血管壁硬化。如单纯血管壁硬化而无高血压则应是革脉或芤脉；如单纯高血压而无动脉硬化则应是弦脉；两者兼而有之才表现为紧脉。紧脉的这种特点致使局部供血不足，如发生在四肢，可引起四肢的挛急、疼痛、麻木、活动不灵等症状；如发生在脑部，可以有头痛头晕等肝阳亢的症状，进一步可有内风症的出现。如发生在内脏，可引起相应脏器的绞痛和功能失调。这些病症多属中医寒证、阳虚、血瘀、痰阻的范围。相当于西医诊断的动脉硬化和周围血管疾病。应说明的是寸口脉的这种变化和全身其它各处的血管变化程度不一定完全一致。

18. 革 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“革脉，弦而芤如按鼓皮。”《诊家正眼》说：“革大弦急，浮取即得；按之乃空，浑如鼓革。”又说：“恰如鼓皮，外则绷紧，内则空虚也。”由此可见，革脉的特点应是血管紧张度高，血管壁硬而坚韧，按之中空。其实亦就是紧脉兼有中空的特点。但一般来说，血管绷紧和中空二者不能兼见。绷紧是脉管充盈度高的结果。所以革脉的血管壁可有一定的硬度，但无弦和绷紧之象。

革脉还应和牢脉相区别。牢脉无血管壁硬和中空之象，以沉取为多见。革脉和芤脉基本相同，只是革脉比芤脉血管壁稍硬而已。

革脉的〔机制〕与〔临床意义〕基本与芤脉相同。

19. 牢 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“牢脉，似沉似伏，实大而长，微弦。”《诊家正眼》说：“牢在沉分，大而弦实，浮中二候，了不可得。”又说：“牢有二义，坚牢固实之义，又深居在内之义。”总结以上的说法，牢脉应属沉脉或伏脉，重按乃得；具实大的特征（即脉搏充实而大），搏动有力。实脉未尝不兼大，且实脉也可以表现在沉相。这样看牢脉就是实脉兼弦象。可以叫弦实脉。可以认为它是二合脉。

〔机制〕

同弦、长、实脉。牢脉属实脉之类，主要是由于心搏有力，心搏血量多，血管张力大且血管充盈度较高等因素引起。

〔临床意义〕

在临床中一般多把此脉诊为实脉或弦脉，但并非无此脉或此脉少见，而实在是人们都不愿做出此种脉名的诊断。具备此种脉象特点的脉都被诊为其它脉名，所以实际上牢脉等于空有虚名了。

牢脉的见症都以实证为多。可见于身体壮实的人及肝阳偏亢，实热证，积聚初期正气未伤之时。有的书讲牢脉即坚牢之义，主疾病永久坚固难愈。此种说法是把脉的病理意义形而上学化和文字化了。又有人把牢脉的脉象说成是坚牢不移之义，此亦颇费解，血管深在脉搏可能比较固定，但把脉搏说成坚牢不移是欠妥的。《中医脉学研究》主张牢脉应见于动脉硬化，可是从各脉学书籍的记载看好像牢脉无脉硬之

意。不过牢脉有紧张之象，见于高血压倒是完全可以的。

20. 缓 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“缓脉，来去小驶于迟。一息四至，……应指和缓，往来甚匀。”《诊家枢要》说：“缓，不紧也，往来舒缓。”《诊家正眼》说：“缓脉四至，来往和匀；微风轻飏，初春杨柳。”综上所述缓脉的脉率应是一息四至，更正确的说应是一息四、五至，即每分钟60~100次；节律均匀而形态和缓而不紧、不硬。该脉比迟脉脉率快，比软脉大而有力，此虚脉充实有力。

〔机制〕

缓脉的脉率是正常心搏频率。脉来和缓均匀、不紧不硬，说明心搏的节律均匀，血管壁柔软而血管充盈良好，此皆健康的正常脉搏表现。

〔临床意义〕

根据该脉象的特点和机制，缓脉不应是病脉。如《濒湖脉学白话解》说：“不管什么脉象，只要是具有从容和缓气象的便是神气还在，缓脉的本身就是神气充足的反映，也就是正常的和缓脉象。”又说：“……讨论的缓脉，是属于正常的和缓脉象，并不是病脉。”《诊家正眼》说：“又一切脉中皆须挟缓，谓之胃气；……有胃气则生，无胃气则死，缓之于脉大矣哉！是故缓脉不主疾病，惟考其兼见之脉，乃可断其为病耳。”以上文字都说明缓脉是有胃气、有神的表示，不是病脉，故应将该脉称为正常脉象。

21. 促脉、结脉、代脉

〔脉象〕

此三部脉虽各有区别，但它们都是节律不整之脉，都有休止，因此放在一起讨论，以便于比较。《濒湖脉学》说：“促脉，来去数，时一止复来，……徐疾不常。”《诊家正眼》和《脉经》等与上述说法相同。总之，促脉的特点是脉率快且节律不规则，时有脉搏休止，止无定数。结脉是脉率较缓慢的，时有休止，止无定数。代脉是脉率可快可慢，止有定数。休止时间较长。

上三脉的共同特点是都有休止。其不同点是促脉和结脉都止无定数，代脉是止有定数，促脉脉率较快；结脉脉率较慢；代脉可快可慢。一般来说这三部脉两手三部不会有区别。

〔机制〕

脉搏的休止主要是由心室收缩的休止或无效收缩，心排血量少不能引起脉搏等因素引起。从心电图上看，早搏、窦性停搏、窦房阻滞，Ⅱ度二型房室传导阻滞，双束枝传导阻滞，心房纤颤等都可以产生上述的脉搏休止现象。其中以早搏为最多见。就其特点而言，促脉是快速心率加休止；结脉是慢速的心率加休止；而代脉是休止固定并间歇较长。休止固定是指二联律、三联律和Ⅱ度二型房室传导阻滞等。歇止时间长是代偿间歇完整。这三种节律不整的脉可以由不同疾病引起。也可由一个疾病在不同时期互相转换。

〔临床意义〕

传统的说法认为促为热极，结为阴极，代为脏气衰微，其实未必。

(1) 上述三种脉象皆可见于心血瘀阻、肝阳上亢、心气虚，心阴虚诸证。如中医诊断可见心痹，真心痛，温毒之邪内舍于心等证；西医诊断可见冠心病，风湿性心脏病，高血压性心脏病、各种原因的心肌炎等。这些疾病分属中医寒、热、虚、实证，而且这些疾病的病理变化无论中医、西医机制都不尽相同，所以这些脉的病因诊断意义并不大。

(2) 可因情志、饮食不节、饮酒、喝浓茶、过劳和某些药物因素引起。在上述情况时结、代、促脉多为一过性出现，并不伴有其它病态表现。

(3) 传统脉学认为可根据脉搏动、止的次数而判定病人几日死，这是无道理的。本脉的预后意义应以引起该脉的心律失常类型和原发疾病的种类而定。

我们统计的 200 例住院病人的脉象中有结、代脉三例，在不同时期结、代二脉互有转变。此三例的中医诊断是心悸、心痹；西医诊断是甲亢性心脏病伴心房纤颤 2 例，风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴心房纤颤 1 例。

22. 散 脉

〔脉象〕

《濒湖脉学》说：“散脉大而散，有表无理。涣散不收。无统纪、无拘束，至数不齐，或来多去少，或去多来少……。”又说：“总之，散脉不外两大特点：一是脉的搏动极不整齐，不是来多去少，就是去多来少，也就是脉搏的一来一去

不十分清楚；一是浮而虚大，好似杨花的飘散无根，渐轻渐有，渐重渐无，散漫到了极点。”总之，散脉的特点应是脉来大小、强弱极不一致、节律极不规整而浮弱无力；脉率快慢也极不一致。

〔机制〕

散脉的特点和心房纤维性颤动的脉搏特点基本相同。在心房纤颤时，由于房室间存在着极不规则的传导、隐匿传导、干扰等因素，致使心室的收缩快慢、强弱和节律极不一致；故使心脏的每次排血量也极不一致。如果心室的收缩很弱而不完全，排血量很少，则不引起或者引起极弱的脉搏。如心房的兴奋传至心室时值心室处在应激期，则下达可引起心室收缩发生脉搏。若心房的激动传至心室时值心室的不应期，则不引起心室收缩和脉搏。中医认为这种脉搏散乱不规则的现象由于神气散乱不收引起。

〔临床意义〕

散脉主要是由于心房纤颤引起、其中医诊断可见心痹，真心痛，心悸，水肿，积聚，喘证，饮证，膨胀等证；西医诊断可见风湿性心脏病二尖瓣狭窄，冠心病，甲状腺机能亢进性心脏病，高血压性心脏病，慢性缩窄性心包炎，洋地黄中毒，先天性心脏病和心肌病等。总之可出现散脉的疾病甚多，因此散脉的病因诊断意义并不大，但出现散脉的疾病预后均较差。

附：怪脉

《脉学辑要》叙述了七个怪脉，有弹石、解索、雀啄、屋漏、虾游、鱼翔、釜沸。其中弹石即肾的真脏脉，解索基

本与散脉同，釜沸和疾脉无明显区别，雀啄和结，代二脉同，鱼翔脉似乎根本见不到。屋漏和虾游都是脉率极慢的脉，其二息一至，约每分钟10次左右，其实就是濒死前脉搏的偶一跳。据临床所见，有的病人濒死时心脏突然停跳即不再复跳，有的病人在濒死前可有一段时间呈现类似屋漏脉和虾游脉的特点（偶有一跳直至心脏完全停搏）。这两种脉正因为出现在濒死前的暂短时间内，所以很难见到。一般脉书都不把它们单列出来。

另外有的脉书尚列十怪脉，亦是极难见到的，这里不予一一介绍。

八、关于相兼脉象和脉症从舍

一个人同时具有两种以上脉象的特征叫相兼脉，临床上出现相兼脉是常见的。而单一脉却是少见的。因为脉书上描写的每一部脉都是从单一的角度出发，而临床所见到病人的每个脉搏是从多方面表现的综合体，所以出现相兼脉也是必然的。最常见的相兼脉是二合脉如浮缓、浮紧；三合脉如沉细数、沉迟紧等；四合脉是少见的。相兼脉的主病一般来说是各脉主病的相加，如一部脉主多种疾病应以主要疾病为主。如浮紧主表寒，沉细数主里阴虚有热等。

关于脉症从舍，过去的说法认为，当脉症不相合（相反）时，则必须有一从、有一舍，这种说法现在看来并不合。因为不论是证或是脉，都是人体生理或病理的反应，都是很重要的客观材料。它对我们了解人体的健康情况和病理情况都是很重要的依据。都不可舍去。脉症相反时，并非必有一假，亦可为两种情况都存在。如腹中有形的实体肿块为实证，但呈虚脉，尽管这种脉症相反，然而却反应了体内的真实情况——邪气实，正气虚。有时我们过去认为是相反的东西而实质都是相同的。如心悸气短、面白、肢冷、水肿等虚寒症状，而呈数脉，这里好像是寒热相反，其实这种脉症恰恰都是虚寒症的真实反应。数脉在这里并非主热，而恰恰

是虚寒的真实反应。过去认为数主热是对数脉不全面的认识。这一点过去我们没有能认识到。因此我们对脉象的客观规律应不断认识、不断总结，不可认为过去的结论是一成不变的。

附 主要参考书目

- ✓ 《黄帝内经素问集注》清·张隐庵 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《难经译释》南京中医学院医经教研组 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《伤寒论集注》清·张隐庵 人民卫生出版社出版
- ✓ 《金匱要略语译》中医研究院 人民卫生出版社出版
- ✓ 《脉经》晋·王叔和 商务印书馆出版
- ✓ 《脉诀汇辨》清·李延昆 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《脉诀刊误》元·戴启宗 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《脉学辑要》丹波无简 人民卫生出版社出版
- ✓ 《濒湖脉学白话解》北京中医学院中医基础教研室人民卫生出版社出版
- ✓ 《诊家正眼》明·李中梓 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《诊家枢要》元·滑寿 科技卫生出版社出版
- ✓ 《三指禅》清·周学霆 人民卫生出版社出版
- ✓ 《脉学研究十讲》任应秋 上海卫生出版社出版
- ✓ 《脉诊选要》上海中医文献研究馆 上海科学技术出版社出版
- ✓ 《谈切脉》张翼 青海人民出版社出版
- ✓ 《四诊抉微》清·林之翰 人民卫生出版社出版
- ✓ 《脉义简摩》清·周学海
- ✓ 《灵枢经白话解》陈壁疏等 人民卫生出版社出版
- ✓ 《中医脉学研究》崔玉田等 河北人民出版社出版
- ✓ 《诊宗三昧》清·张璐